

Conducta suicida y autolesiones

MarcoclinicoDBT - Evaluacionyjerarquiadeintervencion

JERARQUIA DE OBJETIVOS EN DBT

DBT establece una jerarquia clara de objetivos que ordena el trabajo terapeutico. Las conductas que amenazan la vida siempre tienen prioridad sobre cualquier otro tema, independientemente de lo que el paciente quiera trabajar en la sesion.

1

Conductas que amenazan la vida

Intentos de suicidio, parasuicidio, ideacion activa con plan, autolesiones de riesgo vital.

2

Conductas que interfieren la terapia

Faltar a sesiones, no hacer tareas, conductas que dañan la relacion terapeutica.

3

Conductas que interfieren la calidad de vida

Problemas de vivienda, salud, trabajo, relaciones que impiden el progreso.

4

Desarrollo de habilidades DBT

Aprender y generalizar las habilidades de los cuatro modulos.

DISTINCION CLINICA CLAVE: SUICIDIO VS. AUTOLESION NO SUICIDA

Dimension	Autolesion no suicida	Conducta suicida
Funcion	Regular emociones, comunicar dolor	Escapar de la vida / morir
Intencionalidad	Sin intencion de morir	Con intencion de morir
Metodo	Habitualmente bajo riesgo medico	Variable, puede ser alto riesgo
Frecuencia	Puede ser habitual/cronica	Episodica o unica
Intervencion DBT	Analisis en cadena + habilidades	Protocolo suicida + seguridad

ANALISIS EN CADENA PARA CONDUCTAS OBJETIVO

- Paso 1: Describir la conducta objetivo especificamente (que, cuando, donde, con quien).
- Paso 2: Identificar el evento vulnerabilizante (factor de fondo que aumento la vulnerabilidad).
- Paso 3: Identificar el evento precipitante (que disparo la cadena).
- Paso 4: Mapear la cadena: pensamientos, emociones, sensaciones, conductas.
- Paso 5: Identificar donde (dentro de la cadena) una habilidad DBT podria haber interrumpido el ciclo.
- Paso 6: Plan de accion: que habilidad usara el paciente la proxima vez en ese punto.